BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

CHĂM SÓC BỆNH LIỆT VII NGOẠI BIÊN

Mã đề xuất CS-TMH-05; bản trình thẩm định 14/10/2026. Chưa ban hành. Biên soạn/thẩm định/phê duyệt: ……

Áp dụng chăm sóc điều dưỡng theo bệnh, gồm nhận định, chẩn đoán điều dưỡng, lập kế hoạch, thực hiện và đánh giá. Kỹ thuật xâm lấn phải có quy trình riêng theo QĐ3023, chỉ định và người đủ phạm vi/năng lực; bộ này không cho phép điều dưỡng tự chẩn đoán hoặc quyết định điều trị.

ICD: G51.0

1. Nhận định

Xác nhận hai định danh, lý do đến khám, khởi phát, bệnh nền, thuốc/dị ứng; đánh giá ABCDE, sinh hiệu, đau, ăn/nuốt, dịch vào-ra và nguy cơ té ngã theo tình trạng. Báo ngay khi khó thở, thở rít, tím, giảm ý thức, chảy máu nhiều hoặc dấu giảm tưới máu. Cận lâm sàng theo bác sĩ.

- Khai thác bệnh có sốt không có tăng huyết áp không, có từng phẫu thuật gì không , có từng chấn thương không, có viêm tai giữa không, có tăng huyết áp không, có từng bị zona không

Bác sĩ đánh giá nguyên nhân và lựa chọn xét nghiệm khi cần; không chụp CT/x-quang xoang thường quy cho mọi liệt VII. Ghi khởi phát, yếu chi, nói khó, chóng mặt và dấu thần kinh mới để báo cấp cứu khi nghi đột quỵ.

2. Chẩn đoán điều dưỡng

2.1.Người bệnh tự ti về gương mặt

2.2.Có nguy cơ biến chứng không hồi phục như ban đầu

2.3.Thiếu kiến thức về bệnh

3. Lập kế hoạch chăm sóc

Đặt mục tiêu cá thể và thời điểm đánh giá: hô hấp/tuần hoàn ổn định, triệu chứng giảm so với ban đầu, dung nạp ăn/uống phù hợp, không xuất hiện dấu nguy hiểm, người bệnh/người chăm sóc hiểu kế hoạch. Phân công người thực hiện và tần suất theo dõi theo nguy cơ/y lệnh.

3.1.Người bệnh tự ti về gương mặt

3.2.Giảm nguy cơ biến chứng không hồi phục như ban đầu

3.3.Cung cấp kiến thức cho người bệnh

4. Thực hiện kế hoạch chăm sóc

4.1.Người bệnh tự ti về gương mặt

- Hướng dẫn người bệnh uống thuốc, tái khám , tập thể dục , tập phục hồi chức năng

- Vệ sinh răng miệng

Đánh giá nuốt và chăm sóc răng miệng phù hợp; không khí dung/súc họng bắt buộc cho mọi liệt VII.

Không dùng thuốc kháng dị ứng, xông hoặc hút mũi thường quy chỉ vì liệt VII; điều trị theo nguyên nhân và y lệnh.

4.2. Giảm nguy cơ xảy ra biến chứng

Đánh giá nhắm mắt, khô mắt, đau/đỏ và thị lực. Khi nhắm mắt không kín: bảo vệ giác mạc, dùng chất bôi trơn và hỗ trợ nhắm mắt theo chỉ định; hướng dẫn thao tác không gây áp lực hoặc chạm giác mạc. Đau/đỏ mắt, nhìn mờ cần khám Mắt khẩn.

4.3.Cung cấp kiến thức cho người bệnh

Giải thích nguy cơ và thời gian hồi phục tùy nguyên nhân; không khẳng định bệnh chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ hoặc chắc chắn hồi phục hoàn toàn.

- Cho người bệnh uống nhiều nước trái cây cung cấp nhiều vitamin tăng cường sức đề kháng

- Tuân thủ theo theo phác đồ điều trị

- Không tự ý bỏ thuốc , đấp thuốc gây bỏng da nhiễm trùng

5. Đánh giá

- Bệnh hết yên tâm hơn

Đánh giá hiểu biết, bảo vệ mắt, ăn uống và thay đổi vận động mặt; ghi diễn biến, không cam kết gương mặt trở lại ban đầu.

- Bệnh ăn uống khá

Ghi kết quả theo từng mục tiêu, triệu chứng/sinh hiệu trước và sau, mức ăn uống và nhu cầu hỗ trợ; điều chỉnh kế hoạch khi chưa đạt hoặc có vấn đề mới. Không ghi chung “khỏe hơn” để thay giá trị theo dõi.

Ghi chép bàn giao và hướng dẫn sau chăm sóc

Ghi nhận định, vấn đề, mục tiêu, thuốc/can thiệp, đáp ứng và thời điểm báo bác sĩ; bàn giao ISBAR, nơi và người tiếp nhận khi chuyển. Hướng dẫn đúng đơn, lịch tái khám cụ thể và dấu nguy hiểm; yêu cầu người chăm sóc nhắc lại. Không đợi hết thuốc khi có dấu xấu đi.

Căn cứ và nội dung cần xác nhận

Thông tư 31/2021/TT-BYT về hoạt động điều dưỡng: https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956 . QĐ3023/QĐ-BYT dùng cho đề cương kỹ thuật khi có quy trình kỹ thuật riêng, không dùng để xác lập mọi can thiệp chăm sóc bệnh lý.

Nguồn chuyên môn tham khảo: https://www.entnet.org/quality-practice/quality-products/clinical-practice-guidelines/bells-palsy/. Áp dụng theo đối tượng và hoàn cảnh của hướng dẫn, không thay thế chỉ định bác sĩ hoặc quy định của bệnh viện.

Khoa TMH xác nhận chẩn đoán/mã ICD, danh mục kỹ thuật được phép, thuốc và kế hoạch theo dõi theo tuổi. Các chẩn đoán điều dưỡng trong nguồn là gợi ý, chỉ chọn khi có dữ liệu thực tế; không mặc định mọi người bệnh đều có tất cả vấn đề.

Người thẩm định/chữ ký/ngày: …… Số quyết định/ngày hiệu lực: ……